FACULTE DE MEDECINE

HISTOIRE DES HOPITAUX

DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS

Module **Santé Société Humanité**

Année universitaire **2019/2020**

Dr GANI.S

HISTOIRE DES HOPITAUX
DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS

I. INTRODUCTION

Si ces dernières années son image est ternie, l'hôpital reste investi de sa mission de service public qui l'honore : dernier recours lorsque tout est saturé, il doit faire face.
De plus il est le lieu irremplaçable de l'enseignement professionnel et de la formation des praticiens.
Dans la société actuelle, l'hôpital demeure la dernière lumière allumée, 24h/24, 365 jours/an et ceci depuis bien des siècles.

Beaucoup de nos hôpitaux ont été construits depuis plus d'un siècle (CHU Mustapha, CHU Bab El Oued, CHU d'Oran).

II. LE DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DES HOPITAUX

L'initiative de la création d'établissements pour les voyageurs pèlerins et les malades pauvres remonte à la création des grands monastères bouddhiques en Inde, à Ceylan et dans l'empire khmer, à partir du IIIème siècle avant J-C.

Dans la Grèce ancienne, soins et religions étaient étroitement mêlés : le dieu de la médecine Asclépios (**Esculape**) était vénéré à Epidaure où les pèlerins venant de toute la Grèce pour se faire soigner et consulter des médecins. En ces endroits, appelés asklépieia les pèlerins venaient chercher la guérison de leur mal.

A la période romaine, il existait des maisons de santé et des lieux de soins pour les esclaves et les militaires.

A l'époque byzantine, à partir du IIIème siècle après JC se développaient des lieux d'accueil (destinés aux pauvres, aux vagabonds et aux victimes des famines) dirigés par un ermite donc administrés par l'église (infirmerie ou hôpital).

III. LES HOPITAUX DANS LE MONDE ARABO-MUSULMAN

Le monde islamique s'organise du VIIème siècle au XIIème siècle ; après l'expansion qui suit la mort du prophète en 362, il s'élabore dans les pays convertis à l'Islam un système d'assistance évolué.
L'hôpital désigné par le terme « **bîmâristân** » ou « **mâristân** » désigne un établissement hospitalier pour les malades dont on espère la guérison.

Le calife omeyade al Walid (705-710) serait le premier à bâtir un bîmâristân en Islam, à y avoir nommé des médecins et à leur avoir alloué un traitement.
Sous le règne de Haroun Er-Rachid (786-809) est créé à Bagdad un bîmâristân qui exerça une profonde influence sur la médecine arabe.

Au Xème siècle, trois hôpitaux sont construits à Bagdad dont le plus célèbre est celui d'Aduda al-dawla (932) qui fonctionne jusqu'au XIIème siècle.

Bien des villes en Islam ont des hôpitaux :

- En Iran : shiraz et Rayy.
- A damas, en Syrie, l'hôpital Nur al-din (XIIème siècle) est un des plus beaux au Moyen-âge, et l'hôpital de Qaymari (1248-1258) est le type parfait du plan cruciforme de stricte symétrie.
- A Alep, il subsiste deux hôpitaux médiévaux : celui de Nur Al-din et celui d'Arghun al-Kamili (XIVème siècle).
- Au Caire, le premier hôpital est construit en 872 par Ahmad ben Tulum. L'hôpital de saladin (le mâristân Nasiri) a aussi deux établissements accolés et possédant des chambres pour les malades : il est doté d'une annexe grillagée pour les malades mentaux.

AU Maghreb le premier grand hôpital fut fondé à Marrakech par l'almohade Ya'qub al-Mansur (fin du XIIème siècle).

Il y a un hôpital à Tunis (1420) et celui de Grenade construit par le nasride Muhammad V en 1367.
En Turquie, les villes d'Anatolie ont des hôpitaux (Dar al-shifa).

Les revenus des hôpitaux proviennent des donations et des waqf constitués à leur profit par les particuliers.

On y soigne surtout : les maladies des yeux, de l'appareil digestif, et des troubles mentaux et l'on y pratique la réduction des fractures. Les malades viennent en consultation externe, certains sont hospitalisés.
Les administrateurs ont des registres sur lesquels sont inscrits les noms des malades, les dépenses pour les remèdes et la nourriture. Les médecins viennent chaque matin, examinent les malades, ordonnent de préparer les remèdes et les aliments qui peuvent guérir.

IV. LES HOPITAUX EN EUROPE AU COURS DES SIECLES

1. **Epoque médiévale** :

Les maisons de charité apparaissent d'abord dans l'orient chrétien, puis en occident à partir du Vème siècle.

Le premier hôpital connu à Paris est l'hôtel-Dieu situé à l'ombre de la cathédrale au bord d'un bras de la seine.

Vers 1260 est fondée une congrégation dite « la maison des pauvres aveugles de Paris » pour l'hébergement de 15 fois 20 patients.

Des le IXe siècle, le mot « hôpital » semble fixé dans les principales langues européennes (hôpital, ospedale).

Le terme hospitalia désigne un logement destiné à un étranger comme lieu d'hospitalité.

En vieux français : **ospital** désignait l'accueil des malades, des indigents et des mourants.

Ce modèle connait son apogée au XIIIe siècle dans l'ensemble de l'Europe occidentale.

Durant tout le Moyen-âge, l'hôpital chrétien est pensé et organisé comme un lieu d'accueil pas comme un centre de soins.

2. **Hôpital de la renaissance et époque classique :**

L'hôpital-palais adopte de nouvelles formes (inspiré du modèle italien) : la croix et la cour.

Chaque corps de bâtiment constitue le bras d'une croix et délimite un espace central : la cour

Ex : l'hospice des incurables (futur hôpital Laënnec est édifié en 1634 et 1639 sur ce modèle).

Pour lutter contre l'expansion de la lèpre dans l'ensemble de l'Europe, les maladreries et les léproseries se multiplient dans la première moitié du XII e siècle.

Le retour brutal de la peste en 1347 impose à la république de Venise l'instauration du 1er lazaret pour mettre en quarantaine en 1423 sur un ilot, des passagers et équipages des navires suspects de contagion.

LYON la première fonde en 1614 l'hôpital de la « charité » pour enfermer mendiants et vagabonds ; puis d'autres grandes villes s'inspirèrent de l'exemple Lyonnais.

En 1656 à Paris, le gouvernement royal institue l'hôpital général avec des établissements distincts pour les hommes (Bicêtre), les femmes et les filles (la salpêtrière) et les garçons (la pitié).

En Angleterre en 1670 nait l'institution des « workhouses », son but est de faire en sorte que les pauvres puissent subsister du produit de leur labeur.

3. **Hôpital hygiéniste** : Architecture ventilée à la fin du 18e siècle

L'état de l'hygiène hospitalière était déplorable.

L'hôpital Lariboisière ouvert en 1854 était conçu avec une segmentation des bâtiments indépendants mais reliés par des galeries, sans grandes concentrations et avec une attention particulière à la ventilation.

L'installation de bains, de cabinets d'aisances, de buanderies d'étuves à désinfection ont été conçus dans l'hôpital Tenon et le nouvel hôtel Dieu (objet d'un incendie en 1772) en 1878.

Les hôpitaux deviennent des locaux où s'élabore une nouvelle méthode scientifique : l'anatomo-clinique (confrontations entre les observations cliniques relevées au lit du malade et les données anatomiques recueillies sur le cadavre. Cette méthode est utilisée surtout par un italien Giovanni-Battista

A Paris, la reforme hospitalière engagée en 1801 amorce la spécialisation des structures par pathologie et les internes qui étaient chargés de recenser les données cliniques et anatomo-cliniques ont permis de faire progresser la connaissance des maladies.

4. **L'hôpital pavillonnaire :** de la fin du 19e siècle.

Les travaux de Louis Pasteur démontrent la nécessité de combattre la contagion en séparant les malades et en stérilisant les outils médicaux. Chaque maladie, puis chaque malade est isolé au sein des pavillons.

En Algérie, les hôpitaux Mustapha d'Alger et l'hôpital Saint Lazare d'Oran sont construits sur ce modèle.

5. **L'hôpital monobloc** : symbole de la médecine triomphante.

Dans la première moitié du XXe siècle, les victoires contre la contagion hospitalière et la découverte des antibiotiques a eu raison petit à petit des hôpitaux villas.

L'intégration de la dimension économique de la santé dans la construction des hôpitaux engendre un nouveau modèle, conçu aux Etats-Unis dans lequel la rationalisation des fonctions et des coûts s'exprime par la verticalité. Les pavillons se superposent pour donner naissance aux niveaux : l'hôpital monobloc est né.

Cette architecture hospitalière impose une image toute puissante de la médecine. Il s'agit de bâtiments fortement technologiques comme l'hôpital Henri Mondor à Créteil (1969).

6. **L'hôpital polybloc** : ouvert sur la ville

Dés 1980, les concepteurs architecturaux choisissent de prolonger la ville dans l'hôpital en organisant les fonctions le long d'une vaste rue intérieure.

L'hôpital Européen George Pompidou est conçu par un ensemble de bâtiments reliés les uns aux autres par des cours intérieures ; l'organisation de l'espace est facilitée par une rue hospitalière piétonne couverte d'une verrière qui relie les trois entrées de l'établissement.

V. LES HOPITAUX EN ALGERIE

Avant la colonisation française (1830), des établissements de soins existaient en Algérie, en particulier à Alger, Tlemcen, Oran, et Bejaia

Alger en comptait au moins cinq pour les étrangers et cinq pour les autochtones.

A Alger la première structure hospitalière ottomane fut construite en 1550 par Hassan fils de Kheir Eddine Barberousse.

Cet hôpital, qui était situé à la basse casbah près de la rue Bab-Azzoun continuera de fonctionner pour la population civile jusqu'en 1854 sous l'appellation d'Hôpital Caratine.

En plus de cet hôpital, il y avait plusieurs asiles :

- L'asile pour malades mentaux
- L'asile pour les janissaires invalides
- L'asile refuge des indigents
- L'asile des handicapés

Avec l'occupation française, apparaissent les premiers hôpitaux militaires dans un premier temps puis des hôpitaux mixtes et enfin des hôpitaux civils destinés d'abord aux colons et par la suite à la population autochtone.

En 1850, les hôpitaux militaires étaient au nombre de 33, fonctionnant avec 418 médecins.

Au fur et à mesure de l'installation des colons, des hôpitaux civils verront le jour : Hôpital Mustapha en 1854, celui de Annaba en 1858, ceux de Témouchent et de Sig en 1861, celui de Constantine en 1869, celui de Bejaia en 1870 et celui d'Oran en 1883.

En 1920, on comptait 21 hôpitaux et hospices civils.

En 1930, on comptait 19 hôpitaux civils et 33 militaires

A la veille du déclenchement de la guerre de libération nationale, on comptait : un hôpital universitaire de 2000 lits à Alger, trois grands hôpitaux de chef lieu : Alger, Oran, Constantine, 112 hôpitaux généraux, 114 hôpitaux spécialisés (sanatoria et centres psychiatriques) ; la santé militaire s'appuyait sur les hôpitaux militaires (Maillot à Alger, Baudens à Oran, Laveran à Constantine et 17 hôpitaux et antennes chirurgicales assurant un maillage du territoire.

Au 30 Décembre 1996, on comptait, 176 hôpitaux régionaux, 9 cliniques, 13 CHU, 21 hôpitaux spécialisés.

La capacité hospitalière était de 1,8 lit/1000 habitants en 2014.

Elle serait actuellement de 2 lits/1000 habitants. Comparée à celle des pays de l'OCDE, on constate que seule la Turquie, la Suède et le Royaume-Uni ont une capacité voisine respectivement de 2.2, 2.4, 2.5

Pour les autres pays cette capacité varie entre 3 à 7 lits/1000 habitants

1- Les différentes catégories d'hôpitaux en Algérie :

Il y a lieu de distinguer les hôpitaux généraux (EPH : établissement public hospitalier), les hôpitaux spécialisés (EHS de psychiatrie, d'oncologie, de rééducation fonctionnelle, mère et enfants, cliniques des brûlés) et les hôpitaux universitaire (CHU, EPH ou EHS) auquel il faut ajouter quelques hôpitaux au statut particulier : les EH (EHU d'Oran, EH de Ain Témouchent)

A ces 3 catégories principales, il faut ajouter les hôpitaux rattachés à des ministères autres que la santé (ministère de la défense, ministère de l'intérieur) ainsi que des hôpitaux ou cliniques du secteur libéral au nombre de 167.

a) Les hôpitaux généraux : (EPH)

Ils reçoivent les patients 24h sur 24h pour une aide médicale.

Ces hôpitaux disposent de 240, 120 ou 60 lits pour les plus récents. Dans certaines Wilayas, d'anciens hôpitaux disposent de plus de 300 lits.

Ces hôpitaux doivent posséder au moins un service de chirurgie, de médecine interne, de pédiatrie et de maternité (sauf si dans la même ville il existe un EHS mère et enfant).

Les activités comme : urgences médico-chirurgicales, anesthésiologie, radiologie, activités en biologie clinique et en officine hospitalière, doivent être présentes dans un hôpital de base.

b) Les hôpitaux spécialisés :(EHS)

Ils dispensent des traitements et des soins aux personnes atteintes de pathologie spécifiques : troubles psychiques, affections néoplasiques …). Outre l'hospitalisation à temps plein et les soins, l'hôpital spécialisé assure des consultations et traitements de jour.

c) Les hôpitaux universitaires : (CHU, EPHU, EHSU)

Traitent et soignent des patients et contribuent à la formation des médecins et des praticiens, à la recherche scientifique et participent au développement de nouvelles technologies.

Dans chaque ville universitaire qui dispose d'une faculté de médecine, un ou plusieurs hôpitaux peuvent être désigné en qualité d'hôpital universitaire.

d) Les polycliniques : (EPSP)

2- Les services médicaux et médico-techniques :

Ce sont les services d'imagerie médicale et les services de radiographie, ainsi que les centres pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique (centres de dialyse).

L'hôpital comporte d'autres fonctions : l'officine hospitalière, la banque de sang, le laboratoire d'explorations biologiques, un service des urgences médico-chirurgicales etc….

Chaque hôpital est tenu de disposer d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales **(CLIN)** présidé par le chef d'établissement et composé du président du conseil scientifique ou conseil médical, du chef de service d'épidémiologie, du responsable chargé de la pharmacie, d'un praticien représentant des spécialités chirurgicales, d'un coordinateur des activités paramédicales, du responsable chargé des infrastructures et équipements, de l'ingénieur biomédical et de maintenance.

Le CLIN est chargé d'identifier et de surveiller les infections nosocomiales et d'en déterminer la prévalence, d'élaborer, de proposer un programme de lutte contre les infections nosocomiales, d'évaluer les résultats des actions entreprises et d'en faire rapport au chef d'établissement.

3- Les modalités d'accès à l'hôpital :

Si en Algérie et dans beaucoup d'autres pays, le malade peut s'adresser de son propre chef à la consultation externe hospitalière. Il n'en est pas de même en Grande-Bretagne, en Espagne ni

dans les pays nordiques, où seule la prescription du généraliste autorise l'accès à l'hôpital (hors les cas d'urgence).

4- <u>La vétusté de certains hôpitaux en Algérie</u> :

La plupart des hôpitaux en Algérie sont vétustes et ont plus de 100 ans et ne répondent plus aux nouvelles normes de sécurité et sont dépassés par les technologies de la médecine moderne.

VI. <u>CONCEPTION DE L'HOPITAL AU 21e SIECLE</u> : l'hôpital moderne

Les hôpitaux modernes sont conçus pour minimiser les efforts du personnel médical et réduire les risques de contamination.

Le bâtiment doit intégrer des bâtiments lourds, comme la radiologie et les blocs opératoires, ceci implique qu'il faut prendre en compte les spécificités en termes de raccordements électriques, de plomberie et de gestion des déchets.

Dans leur conception, les hôpitaux doivent avoir des architectures qui prennent en compte la psychologie des patients, comme une meilleure aération, des vues plus dégagées ou encore de couleurs plus agréables à l'œil.

De même, l'hôpital du XXIe siècle doit être un hôpital intelligent avec le développement de la télémédecine.

La tendance est au regroupement par disciplines au lieu et place des services par spécialité. L'hôpital militaire d'Ain Naadja et surtout l'EHU d'Oran sont ainsi conçus. C'est un regroupement par pôles : on peut citer :

- - Le pôle « mère et enfant »
  - Le pôle traumatologie-orthopédie-rhumatologie (pôle os).
  - Le pôle digestif : chirurgie viscérale – pathologies digestives.
  - Le pôle urologie néphrologie métabolisme : diabétologie – néphrologie – hémodialyse.
  - Le pôle cardio-vasculaire, thoracique et métabolique.
  - Le pôle neuroscience, tête et cou.

Cette organisation permet de favoriser la coordination entre le personnel soignant et l'élaboration d'axes de recherche communs.

VII. <u>L'HOPITAL ET LA SOCIETE :</u>

L'hôpital est perçu comme un lieu où est proposé un service public.

Les soins qui y sont dispensés sont accessibles à tous. L'annonce de la fermeture d'un service est souvent mal reçue par les populations.

L'hôpital accueille des populations très hétérogènes : accidentés (surtout accidentés de la route), personne atteintes de maladies graves (cœur, maladies chroniques etc.) et de très nombreux patients qui viennent consulter des spécialistes et subir des examens approfondis.

L'hôpital accueille aussi les femmes sur le point d'accoucher et les personnes âgées dont l'état général exige des soins constants.

« **L'hôpital est devenu le lieu où l'on nait et celui où l'en meurt**. »

VIII. CONCLLUSION :

Les hospices, asiles, lazarets et léproseries répondaient plus à une préoccupation d'isoler les malades, les pauvres et les malades mentaux plutôt qu'à leur offrir un espoir d'une véritable guérison.

Les Bîmâristâns de la médecine arabo-musulmane sont considérés comme les premiers hôpitaux au sens moderne du terme.

Les premiers hôpitaux publics, les premiers hôpitaux psychiatriques, les écoles de médecine et l'enseignement au lit de malade ont également été introduits par les médecins musulmans.

L'hôpital de demain : pourra être une ressource dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Il se fondera sur un système d'information performant (le dossier médical partagé) et ouvert sur l'extérieur (la télémédecine).

Actuellement se pose la question de la place accordée au secteur hospitalier privé ; aujourd'hui les cliniques privées occupent une place de plus en plus importante dans le système de santé ; mais l'absence de couverture maladie lorsque les soins sont effectués dans le secteur libéral pose le problème de l'égalité des soins pour tous.